

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5104333-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: DOUGLAS DE SOUZA BARBOSA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A RÉ PROVIDENCIE SUA TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA OU HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA, PARA REALIZAÇÃO DAS CIRURGIAS. NEOPLASIA LIPOMATOSA BENIGNA DA PELE E TECIDO SUBCUTÂNEO DOS MEMBROS. PARTE JÁ FOI DEVIDAMENTE REGULADA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ. NÃO HÁ AINDA INFORMAÇÃO SUBSTANCIAL DE QUE O HOSPITAL DO ANDARAÍ NÃO TEM ESTRUTURA PARA TAL PRETENSÃO MÉDICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. NÃO CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANTIDA DECISÃO DE INDEFERIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER dos recurso e NEGAR-LHE provimento, para manter incólume a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5104333-06.2024.4.02.5101

510015321006 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5104333-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: DOUGLAS DE SOUZA BARBOSA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) interposta pela parte autora, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que a ré providencie sua transferência para o Hospital Federal de Ipanema ou Hospital Federal da Lagoa, para realização das cirurgias que necessita.

O juízo de origem proferiu a decisão nos seguintes termos:

*Trata-se de ação pelo procedimento sumaríssimo ajuizada por **DOUGLAS DE SOUZA BARBOSA**, pelo rito comum, em face da **UNIÃO**, em que requer seja deferida tutela de urgência para que a ré providencie sua transferência para o Hospital Federal de Ipanema ou Hospital Federal da Lagoa, para realização das cirurgias que necessita.*

*Para tanto, afirma que apresenta lipomas em ambas as regiões axilares, bem como nódulos em "áreas delicadas do corpo, incluindo pescoço e a região lombar". Aduz, ainda que "Esses lipomas encontram-se em estreita proximidade com **linfomas**, que são tumores malignos do sistema linfático."*

Afirma que os referidos nódulos ocasionam compressão em tendões e nervos, limitando o movimento dos dedos e causando dores contínuas.

Requeru gratuidade de justiça.

Certidão do Evento 5 com informações dos serviços de regulação.

No Evento 6 foi determinada a intimação da parte autora para apresentar documentos essenciais à propositura da ação e laudo médico atualizado.

Manifestou-se o autor no Evento 9, apresentando documentos, que foram considerados insuficientes, de modo que foi proferido novo despacho no Evento 13, determinando a complementação da instrução do feito, inclusive com expedição de ofício ao Hospital Federal do Andaraí.

Nova manifestação do autor no Evento 16, apresentando documentos.

É o breve relatório. Decido.

Para o deferimento da tutela jurisdicional liminar, impõe-se a demonstração, de plano, de alta probabilidade quanto ao direito pretendido e, ainda, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC), ou do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, por parte do réu (art. 311, I, do CPC).

A questão em apreço deve ser analisada à luz do disposto no art. 196 da Carta Magna, que outorga verdadeiro direito subjetivo aos que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizá-lo (RE-271286/RS, Relator Min. Celso de Mello, DJ 23/08/2000).

Da mesma forma, o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade solidária dos referidos entes públicos.

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990.

Trata-se, portanto, de direito fundamental, consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana e indissociável do direito à vida. Admite-se, pois, que o titular de tal direito possa postular, por meio da via judicial, prestação positiva do Estado que imprima ao comando constitucional eficácia plena.

Por outro lado, não se pode olvidar que o próprio art. 196 em comento estabelece a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nesse diapasão, impende observar a “reserva do possível”, sob pena de ocasionar indesejáveis situações anti-isonômicas.

Com efeito, “o direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões singulares ou atípicas, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, podem comprometer a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei. Para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes” (TRF2, Sexta Turma Especializada, AG - Agravo de Instrumento - 233160, Des. Fed. Nizete Lobato Carmo, DJe 06/02/2014).

Vale dizer que, não obstante a urgência de cada caso concreto, não se pode perder de vista a possibilidade de haver outras urgências ainda maiores aguardando o mesmo tipo de tratamento. Sob esse prisma, a eventual imposição do fornecimento aleatório e indiscriminado de certo tratamento tem o potencial de inviabilizar o próprio sistema de saúde pública, constituído sob a ótica universal.

Por isso, cumpre analisar as peculiaridades de cada caso concreto, partindo-se da premissa de que, via de regra, os médicos do SUS dão atendimento às patologias verificadas. De consequente, a intervenção judicial deve-se limitar a hipóteses de negativa injustificada, sob pena de o Estado ver rompida com toda a sua política de saúde.

No caso concreto, o autor limitou-se a apresentar 01 único laudo médico bastante suscinto (Evento 01, LAUDO2), no qual consta a indicação para “suporte perioperatório multiprofissional devido possível alta complexidade”, havendo no referido documento a sugestão de atendimento junto ao Hospital Federal da Lagoa ou Hospital Federal de Ipanema.

Não há nos autos qualquer documento de indique qual o procedimento cirúrgico a que o autor deva ser submetido, tampouco atestando a urgência de sua realização.

Ao revés, consta do feito a informação no sentido de que o demandante já foi devidamente regulado para atendimento junto ao Hospital Federal do Andaraí, com confirmação de chegada ao local para cirurgia geral partes moles.

Deste modo, entendo que o paciente já se encontra devidamente regulado e, portanto, assistido pela rede pública de saúde de acordo com suas necessidades clínicas, razão pela qual resta afastada, por ora, a possibilidade de deferimento da tutela de urgência, tal como requerida na petição inicial.

Ainda importa destacar que a rede pública de saúde possui sistema de portas abertas para atendimento aos casos de urgência e emergência e, sendo necessário atendimento desta natureza ao autor, o mesmo poderá socorrer-se de quaisquer unidades que prestem tal serviço para acolhimento e tratamento que se fizerem necessários, não havendo, direito subjetivo à seleção de unidade para atendimento, mas apenas de correto direcionamento do paciente àquela unidade que tenha capacidade técnica para realização o atendimento que o quadro clínico do paciente determinar.

Ante o exposto, **INDEFIRO**, por ora, **A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA**.

Retifique-se a classe processual para **PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL**.

Tendo em vista a ausência de resposta do Hospital Federal do Andaraí, **reitere-se o expediente do Evento 17**.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Cite-se a parte ré para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, oferecer resposta. Na mesma oportunidade, intime-se a parte ré para, em igual prazo, manifestar-se sobre a possibilidade de conciliação, bem como fornecer a este juízo toda a documentação de que disponha para o esclarecimento dos fatos trazidos à apreciação do Poder Judiciário, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.259/2001, em especial, as informações administrativas específicas para o caso concreto.

Desde já, **resta preventivamente indeferido de plano pedido de dilação de prazo** para a apresentação dos documentos de defesa e das informações administrativas acima referidas bem como requerimento no sentido de que o órgão administrativo responsável pelo fornecimento da mencionada documentação seja diretamente oficiado por este Juízo, cabendo à parte ré, dentro do razoável prazo de 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, legalmente estabelecido, o encargo quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Apresentada a contestação ou decorrido in albis o prazo, intemem-se as partes para, em 05 dias úteis comuns, indicarem, de modo específico e fundamentado, as provas adicionais que pretendem produzir, com indicação de cada fato que pretendem demonstrar com cada prova ou diligência probatória postulada. Nessa oportunidade, a parte autora poderá manifestar-se sobre a contestação e/ou documentos juntados pela parte ré.

Havendo necessidade de produção de prova pericial simples, **resta previamente autorizada** a designação de perícia na especialidade pertinente, determinando à Secretaria, neste caso, que adote as providências cabíveis para a nomeação do perito responsável, agendamento da data de sua realização e intimação das partes.

Cumprido, venham-me os autos conclusos para sentença.

Em suas razões, a parte autora alega que sofre de uma condição médica severa, caracterizada por lipomas, nódulos e linfomas, que causam dores intensas, restrições motoras e progressão para metástase. Informa que laudos médicos anexados atestam a necessidade de intervenção cirúrgica de alta complexidade e urgência. Alega que o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do sistema SISREG, designou o agravante para o Hospital Federal do Andaraí, unidade sabidamente sucateada e incapacitante de atender demandas de alta complexidade. A unidade apresenta infraestrutura deteriorada, falta de especialistas e fila interna de esperança, onde o agravante ocupa a posição 671, impossibilitando o atendimento em tempo hábil. Requer seja deferida tutela de urgência para que a ré providencie sua transferência para o Hospital Federal de Ipanema ou Hospital Federal da Lagoa, para realização das cirurgias que necessita.

Determinada intimação do NAT, evento 3

Parecer do NAT, evento 8.

Manifestação da parte autora impugnando o Parecer do NAT, evento 9. Alega, em síntese, que o parecer negligencia o princípio da razoabilidade ao transferir para o autor a responsabilidade de buscar solução, desconsiderando o estado crítico da unidade hospitalar. Tal posicionamento é um erro grave, pois é dever do Estado garantir o tratamento de saúde ao autor, não sendo razoável exigir que o mesmo "corra atrás" de soluções por conta própria diante da omissão do poder público. Reitera o pedido de transferência.

Decisão desta Relatora indeferindo a tutela, evento 10.

Embargos de Declaração opostos pela parte autora, evento 16.

Decisão desta Relatora mantendo o indeferimento, evento 18

Contrarrazões da União apresentadas, evento 22, pugnando pelo indeferimento do pleito.

Impugnação da parte autora, evento 24, reiterando a necessidade da transferência. Alega, ainda, ter receio de sofrer danos físicos e emocionais devido à falta de segurança e ao ambiente hostil criado pela presença de moradores de rua e usuários de drogas dentro das instalações do hospital. Alega também ter receio de represálias por parte dos serventuários do hospital, em razão da denúncia feita sobre as condições de insegurança e desordem interna. Pugna pelo deferimento.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O art. 196, da CF/88, norma de aplicabilidade plena, declara o direito à saúde: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, ainda que as ações e serviços públicos de saúde sejam informados pela descentralização, conforme a norma constitucional inscrita no art. 198, I, da CRFB (e repetida no art. 7º, IX, da Lei n.º 8.080/1990), certo é que a própria Carta Magna estabelece uma competência concorrente (art. 24, XII) entre os entes constitutivos da federação para legislar sobre o assunto, bem como a competência material comum aos mesmos para realizar as ações correspondentes.

Tanto assim que a Lei n.º 8.080/1990 discrimina as competências da União Federal em seu artigo 16. Acrescente-se que, no que toca ao financiamento dos serviços de saúde, a União Federal tem participação direta, ainda que os serviços sejam prestados prioritariamente pelos Estados e Municípios.

Logo, a União tem competência não só para traçar regras gerais a serem cumpridas no SUS, como também para promover, quando necessário, a devida assistência em concreto, o que atrai a competência para Justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso I da CF/88.

Os mecanismos de compensação dos entes que atuam no SUS – União, Estados e Municípios – não podem impedir a prestação positiva do Estado.

No mesmo sentido, dispõe o Enunciado 43 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

Enunciado 43: “A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde – SUS.”

Neste sentido, confira-se recente jurisprudência do STF, que ratifica seu posicionamento acerca da solidariedade dos entes públicos no fornecimento de medicamentos, nos seguintes termos:

DECISÃO: Vistos. União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Espírito Santo, que manteve a decisão do juízo monocrático, que indeferiu o chamamento da União para integrar o polo passivo de demanda em que se discute fornecimento de medicamentos. Opostos embargos de declaração (fls. 219/220), foram rejeitados (fls. 223/224). Alega o recorrente violação dos artigos 37, caput, e 198, inciso I, da Constituição Federal. Contra-arrazado (fls. 241 a 247), o recurso extraordinário (fls. 229 a 230) foi admitido (fl. 249). Decido. Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. Não merece prosperar a irresignação. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre legitimidade passiva da União em ação em que se discute a obrigação de fornecer medicamentos, em harmonia com a jurisprudência desta Corte que, no julgamento do RE nº 808.059/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe de 1º/2/11), fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária. Nesse sentido, também, as recentes decisões monocráticas: AI nº 817.241/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 14/10/10; RE nº 839.594/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/3/11, e AI nº 732.582/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17/3/11. Sobre o tema, ainda, anote-se o seguinte

precedente: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTETÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protetória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido” (RE nº 607.381/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 17/6/11) Diga-se, por fim, que nos autos do RE nº 566.471, Relator o Ministro Marco Aurélio, discute-se a possibilidade de condenação de Estados ou municípios ao custeio de medicamentos que não integram a lista daqueles fornecidos gratuitamente pelo sistema de saúde pública. Essa matéria, portanto, não se confunde com a do presente recurso extraordinário, que trata do chamamento da União ao processo e da eventual responsabilidade solidária dos entes da Federação. Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se (STF, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, RE 668603 / ES, data da julgamento: 26/04/2013).

Por óbvio, as questões de saúde são sempre prioritárias e merecem pronta resolução. Porém, diante da impossibilidade fática do Estado solucionar todas as prestações de serviço médico de forma imediata, adotou-se um critério objetivo e justo de ordem de chegada ou de agendamento para cirurgia ou tratamento, sendo o tempo de espera o basilar da prioridade de atendimento, já que o direito à saúde é igualmente importante para os seres humanos.

Com efeito, o critério da ordem de atendimento não estará sujeito à adoção de critérios subjetivos ao arbítrio dos funcionários do SUS, bem como não será influenciado pela insistência de alguns pacientes, que almejam que seu direito à saúde seja prestigiado em detrimento de outros que aguardam a prestação do serviço há mais tempo.

Tal critério de atendimento médico, com respeito à ordem da fila ou lista de espera, visa evitar o privilégio de alguns pacientes em detrimento de outros, seja pelo arbítrio do administrador ou mesmo pela insistência do administrado, garantindo-se o respeito à isonomia entre os administrados, bem como fornecendo as diretrizes de organização para a prestação deste serviço público.

Assim, a ingerência do Poder Judiciário nesta atividade, invertendo a ordem de prioridade de atendimento, sem qualquer motivo de força maior e urgente que justifique esta medida, cedendo apenas à demanda dos jurisdicionados, importa em afronta à separação de poderes, bem como ao princípio da igualdade.

Diversamente, caso a ordem da fila não seja observada, o Judiciário poderá interferir, zelando pelo cumprimento deste critério objetivo. Dessa forma, cabe ao julgador analisar o pedido no caso concreto, sendo certo que a isonomia e a organização dos serviços públicos estarão seriamente comprometidas, caso o Judiciário balize a ordem de atendimento médico de acordo apenas com as reclamações que lhe são submetidas, prejudicando aqueles que pacientemente aguardam pela prestação do serviço público há mais tempo.

Assim, nos casos de risco de morte e de sequelas graves decorrentes da demora do atendimento, devidamente comprovadas, legitimaria, em tese, a alteração de ordem do atendimento, uma vez que a não concessão da tutela antecipada poderia ter efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes.

Isso posto, quando presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, na forma do artigo 300 do CPC, quais sejam, o *fumus boni iuris* decorrente do direito constitucional à saúde e da necessidade de tratamento para a autora e o *periculum in mora*, em razão da urgência do estado da parte, deve-se, indiscutivelmente, prevalecer o direito à vida.

No caso, a parte autora apresentou um laudo médico, Evento 01, LAUDO2 dos autos originários, no qual consta a indicação para "suporte perioperatório multiprofissional devido possível alta complexidade", havendo no referido documento a sugestão de atendimento junto ao Hospital Federal da Lagoa ou Hospital Federal de Ipanema, vejamos:

 **PREFEITURA
DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO**
Secretaria Municipal de Saúde

Receituário

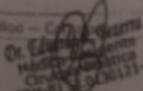
Unidade
Nome <i>Douglas de Souza</i>
Matrícula

Laudo Médico

Paciente apresenta lesões de tecido mole
em regiões axilares, cervical posterior
e dorsal inferior direito (lipoma)
necessitando de suporte perioperato-
rio multiprofissional devido possível
alta complexidade, sendo o
HMBR não o local ideal. Sugere-se
Hospital da Lagoa ou Hospital
de Ipanema.

7

Data: 24/06/24

Assinatura: 
Dr. Eduardo de Souza
Médico Cirurgião
CRM RJ 100111-7

Conforme parecer do NAT, evento 8, foi localizado para o Autor solicitação de consulta em cirurgia geral - partes moles, diagnóstico inicial: **neoplasia lipomatosa benigna da pele e tecido subcutâneo dos membros**, solicitado em 19/06/2024, pelo Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto, **classificação de risco: Azul - atendimento eletivo**, agendada e executada em 28/08/2024, no Hospital Federal do Andaraí. Informa, ainda, que em Evento 36, OFIC1, Página 4 foi anexado ficha de marcação de consulta do Hospital Federal do Andaraí, **com agendamento de consulta - Cirurgia Plástica** em 27/11/2024, vejamos:

Em consulta à plataforma Secretaria Municipal de Saúde – Transparência do SISREG Ambulatorial, foi localizado para o Autor solicitação de **consulta em cirurgia geral - partes moles**, diagnóstico inicial: **neoplasia lipomatosa benigna da pele e tecido subcutâneo dos membros**, solicitado em 19/06/2024, pelo Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto, classificação de risco: Azul – atendimento eletivo, agendada e executada em **28/08/2024**, no **Hospital Federal do Andaraí**.

Assim, entende-se que a via administrativa para o caso em tela já foi utilizada.

Destaca-se que em (Evento 9, LAUDO4, Página 1), consta recorte de tela com a descrição do primeiro nome do Autor “Douglas”, nome da unidade: **Hospital Federal do Andaraí**, nome do procedimento: excisão de tumor de pele e anexos / cisto sebáceo / lipoma, data de entrada **28/08/2024**, status aguardando cirurgia, posição: 667°.

Em (Evento 36, OFIC1, Página 4) foi anexado ficha de marcação de consulta do **Hospital Federal do Andaraí**, com agendamento de consulta – **Cirurgia Plástica em 27/11/2024**.

Desta forma, caso o Autor já esteja sendo atendido pelo Hospital Federal do Andaraí, informa-se que é de sua responsabilidade garantir a continuidade do tratamento do Autor ou, caso não possa absorver a demanda, deverá encaminhá-lo a uma unidade apta em atendê-lo.

Como visto, o autor foi diagnosticado com neoplasia lipomatosa benigna da pele e tecido subcutâneo dos membros.

Outrossim, não há nos autos qualquer documento que ateste a necessidade de urgência na realização da cirurgia, nem tampouco há informação de que o autor esteja com risco iminente de morte.

Lado outro, consta nos autos originários, evento 36, a informação no sentido de que a parte já foi devidamente regulada para atendimento junto ao Hospital Federal do Andaraí, vejamos:



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro
Hospital Federal do Andaraí
Coordenação Assistencial

DESPACHO

HFA/CASS/HFA/DGH/SAES/MS

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2024.

A Direção Geral
Dr. Luiz Felipe Carvalho Matos
Diretor Geral/Ordenador de Despesas

Conforme solicitado do despacho 0044315905 a Área de Cirurgia Plástica Reparadora e Queimados agendou uma consulta para o paciente **Douglas de Souza Barbosa**, prontuário: **1.029.163** a comparecer no dia **27/11/2024 as 09:35 e aguardar o atendimento**, que o mesmo será atendido pelo chefe do serviço **Dr Orido Pinheiro**.
Segue em anexo a marcação.

Atenciosamente,

Orido Luiz Rocha Pinheiro
Médico
Matrícula: 0628419

Outrossim, em petição de evento 50 dos autos originários, a parte autora informa que não tomou conhecimento do referido agendamento.

Não obstante, observo que, conforme determinação do juízo de origem, evento 47, o Hospital Federal de Andaraí foi oficiado, evento 51, *para que, no prazo de 48 horas, indique nova data para realização da avaliação do autor, com antecedência mínima de 15 dias, referentes ao autor Sr. DOUGLAS DE SOUZA BARBOSA, CPF Nº 029031797-51.*

Mister deixar consignado que em casos de pedidos de agendamento de consultas, internação ou intervenção cirúrgica, o papel do judiciário, em regra, é respeitar a decisão do órgão público, que fixa, de acordo com suas possibilidades materiais, critérios para atendimento dos casos que lhe chegam, o que equivale a dizer que o paciente deve se submeter às etapas de avaliação e à indicação de tratamento pela equipe médica do Sistema Único de Saúde.

Assim, a pretensão que acarrete a subtração de etapas do atendimento ou que pretenda a realização de consulta ou tratamento na frente de outras pessoas em igual situação ou simplesmente que tiveram acesso ao SUS antes, não deve, em princípio, merecer acolhida, sob pena de se perturbar, com a decisão judicial, a logística e organização administrativa.

A jurisprudência corrobora este entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. ORGANIZAÇÃO DE FILA DE ESPERA. CONTROLE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela antecipada para que a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro priorizassem o tratamento da parte agravada, aferindo-se o real diagnóstico da enfermidade, e, constatada a necessidade de cirurgia, a realizassem imediatamente, no INTO ou em outra unidade hospitalar apta a efetivar o procedimento cirúrgico.

2. Em instituições e hospitais públicos, devem os pacientes necessitados de cirurgia aguardar o procedimento em fila de espera, organizada segundo critérios técnicos que considerem a entrada, a doença, a gravidade e o procedimento necessário, cabendo à Administração zelar pelo respeito à ordem estabelecida, visando afastar, na medida do possível, o risco à vida daqueles que, prioritariamente, aguardam cirurgias de alta complexidade.

3. Embora notórias as deficiências no SUS, com centenas de pacientes em listas de espera aguardando cirurgias, esse problema de saúde pública não pode e nem deve ser resolvido pelo Poder Judiciário, pena de desestruturar-se o SUS no compromisso de preservar a saúde de um paciente sem desatender outros que também aguardam cirurgia, impondo-se sopesar, tão-somente, se a isonomia está sendo respeitada.

4. Não cabe ao Judiciário, sem conhecimentos médicos ou administrativos próprios, decidir, concretamente, se o paciente-autor deve ser tratado ou operado antes de outro, que também aguarda na fila, salvo quebrando o princípio da isonomia.

5. No exame da omissão ou atraso na realização de procedimentos cirúrgicos necessários, deve o magistrado corrigir somente eventuais vícios na organização da fila de espera para a sua prestação, não bastando, nessas hipóteses, alegações genéricas, sem a efetiva indicação do desvio, pena de se invadir a esfera de competência de outro Poder.

6. No caso, a autora é uma entre dezenas ou centenas de pacientes no mesmo estado de saúde, aguardando tratamento cirúrgico no INTO.

7. Agravo de Instrumento provido. (TRF 2ª Região, 6ª Turma Especializada, AG 2012.02.01.015232-3, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJe 16/01/2013).

Como visto, não há nos autos qualquer documento que ateste a necessidade de urgência na realização da cirurgia, nem tampouco há informação de que o autor esteja com risco iminente de morte.

Por fim, consultando os autos originários, observei que a consulta da parte autora no Hospital Federal do Andaraí foi marcada para o dia 19/02/2025 e que o mesmo será atendido pelo chefe do serviço de Cirurgia Plástica Reparadora, Dr Orido Rocha Pinheiro, evento 50, OFIC1.



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro
Hospital Federal do Andaraí
Coordenação Assistencial

DESPACHO

HFA/CASS/HFA/DGH/SAES/MS

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2024.

À Direção Geral
Dr. Luiz Felipe Carvalho Matos
Diretor Geral/Ordenador de Despesas

Conforme solicitado do despacho (0044875654) a Área de Cirurgia Plástica Reparadora e Queimados agendou uma consulta para o paciente **Douglas de Souza Barbosa**, prontuário: **1.029.163** a comparecer no dia **19/02/2025 às 09:00 e aguardar o atendimento**, que o mesmo será atendido pelo chefe do serviço **Dr Orido Pinheiro**.

Segue em anexo a marcação.

Atenciosamente,

Orido Luiz Rocha Pinheiro
Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora e Queimados

Portanto, não há ainda uma informação substancial de que o hospital do Andaraí não tem estrutura para tal pretensão médica.

Assim, sem prejuízo, ao longo do curso do processo principal, novos exames poderão ser realizados a fim de se verificar o futuro estado da parte autora e somente após a parecer médico demonstrando necessidade, efetuar sua transferência para outro hospital.

Dessa forma, não preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no art. 300 do CPC e entendo que os argumentos da parte autora não são suficientes a gerar a revisão de plano da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, voto por **CONHECER** dos recurso e **NEGAR-LHE** provimento, para manter incólume a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.

5104333-06.2024.4.02.5101

510015321005 .V4